

1 薬剤の分類マップ

細胞障害性抗がん薬
DNA合成・細胞分裂を障害

フッ化ピリミジン系 **S-1** **カペシタビン** 5-FU **FTD/TPI** 白金製剤 オキサリプラチン シスプラチン
 タキサン系・その他 **パクリタキセル** nab-パクリタキセル **イリノテカン**

抗HER2療法

HER2陽性(約20%)に使用

抗HER2抗体 **トラスツマブ** 抗体薬物複合体(ADC) **T-DXd**

血管新生阻害・新規標的
VEGFR-2・Claudin18.2を標的

抗VEGFR-2抗体 **ラムシルマブ** 抗Claudin18.2抗体 **ゾルベツキシマブ**

免疫チェックポイント
阻害薬

PD-L1陽性・MSI-Highなどに使用

抗PD-1抗体 **ニボルマブ** **ペムブロリズマブ**

☐ 経口薬(保険薬局で交付されることが多い) ☐ 注射薬

2 治療ラインの位置づけ(切除不能進行・再発)

対象	1次治療	2次治療	3次治療以降
HER2陽性	フッ化ピリミジン系+白金製剤+トラスツマブ	ラムシルマブ+パクリタキセル、T-DXd	ニボルマブ、FTD/TPI、イリノテカン等
HER2陰性 CLDN18.2陽性	フッ化ピリミジン系+オキサリプラチン+ゾルベツキシマブ	ラムシルマブ+パクリタキセル	ニボルマブ、FTD/TPI、イリノテカン等
HER2陰性 PD-L1陽性等	フッ化ピリミジン系+オキサリプラチン+ニボルマブ(またはペムブロリズマブ)	ラムシルマブ+パクリタキセル	FTD/TPI、イリノテカン等

CLDN18.2とPD-L1がともに陽性の場合の選択は個別に判断。MSI-High例ではペムブロリズマブも選択肢。切除後の術後補助化学療法はS-1(1年)、ドセタキセル+S-1、CAPOX等。

3 副作用の特徴と発現時期

	投与日	1週	2週	3週	1か月	3か月～
● 悪心・嘔吐(シスプラチン)	～5日					
● 悪心・嘔吐(ゾルベツキシマブ)	投与中～当日					
● 急性神経症状(オキサリプラチン)	投与中～数日					
● 好中球減少(nadir)		7～14日目				
● 下痢・口内炎(S-1)		服用2週目以降に多い				
● 流涙・色素沈着(S-1)					数か月の服用で	
● 蓄積性末梢神経障害					累積投与量に依存	
● 間質性肺炎患(T-DXd等)						数週～数か月、時期を問わず

☒ 重篤・特に注意 ☐ その他

押さえておきたいポイント

- 胃癌はHER2・CLDN18.2・PD-L1で1次治療が決まり、2次治療はラムシルマブ+パクリタキセルが軸
- S-1は3成分の配合剤。腎機能での用量調整、休薬日の管理、フッ化ピリミジン系の重複に注意
- ゾルベツキシマブの悪心、T-DXdのILDなど新しい薬剤の副作用と、胃切除後の栄養を薬局で支える